



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : اسماء عادل راشد ابوسريع
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : مصر القديمه
العنوان : -
رقم البطاقة : 29808270103886 رقم التليفون : 01280913522
تاريخ تسجيل الإستمارة : 05-10-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 27-08-1998 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: اسماء عادل راشد ابوسرح National ID: 29808270103886	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

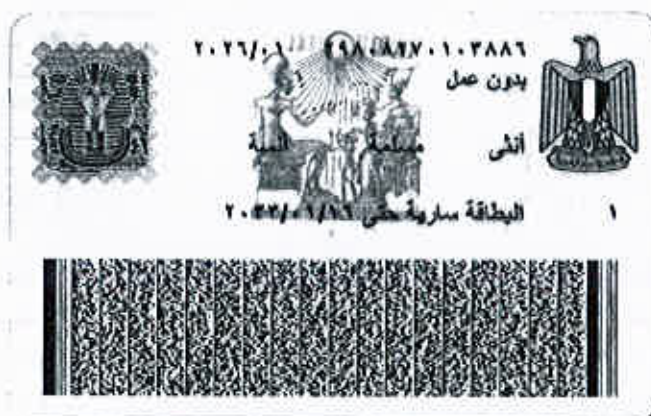
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



مس
أنيش بالصفحة





Patient Name: أسماء عادل راشد

Study Date: 15/06/2026 12:08:18 PM

MRI OF THE BRAIN

Technique:

- Axial T1, T2 & Flair WIs .
- Sagittal T1 WIs & Coronal T2 WIs .
- DWIs & ADC map .
- No contrast was given.

Findings:

- Left temporo-frontal small extra axial cyst of CSF like signals is seen measuring about 1.3x1.5 cm at maximum axial dimensions . Adjacent prominent cortical sulci and extra axial CSF space are seen .
- Another similar extra axial cyst is seen at left posterior parietal para-falcine region measuring about 1x1.1 cm .
- Normal size shape & position of the cerebral ventricles with no midline shift or deformity.
- Normal gray-white matter interface with no areas of abnormal signal intensity.
- Normal MR appearance of temporal lobes and hippocampus regions.
- No gross vascular abnormality,
- Normal cerebellum, brain stem & cervico – medullary junction.
- Normal extra axial spaces.
- Sellar & supra-sellar lesion is seen with left para-sellar extension

Opinion:

- Sellar & supra-sellar lesion with left para-sellar extension for further dedicated enhanced MRI sella assessment.
- Left temporo-frontal and Left posterior parietal small extra axial cysts of CSF like signals likely small arachnoid cysts .

Dr. Ahmed El-Deeb, MD.

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



اسماء
عادل راشد ابوسريع
٢٧ ح الشراقوه
مصر القديمة - القاهرة

١٩٩٨/٠٨

٢٩٨٠٨٢٧٠١٠٣٨٨٦

LP0362951





Patient Name: أسماء عادل راشد

Study Date: 18/07/2026 07:50:44 PM

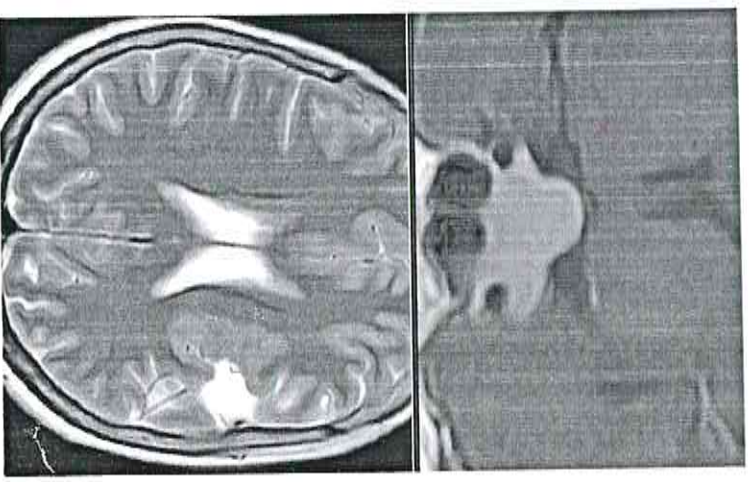
DYNAMIC M.R.I. OF THE SELLA TURCICA

Technique: Sagittal T1 & T2. Coronal T1 & T2. Post I.V. Contrast dynamic WIs.

Findings:

* Large sellar, suprasellar, and left parasellar enhancing soft tissue mass lesion measuring approximately $2.4 \times 2.5 \times 2.8$ cm. The lesion demonstrates mass effect upon the optic chiasm and impression upon the left medial temporal lobe. The mass extends into the left cavernous sinus with encasement of the cavernous segment of the left internal carotid artery, without definite evidence of arterial narrowing or occlusion. The lesion shows inferior extension with encroachment upon the superior aspect of the left sphenoid sinus/cavity. The pituitary gland and stalk are not separately delineated from the lesion.

* Additional abnormal cortical sulcal and gyral configuration is noted at the superior aspect of the left Sylvian cistern region, associated with prominence of the overlying extra-axial CSF spaces.



Conclusion:

≈ Large enhancing sellar, suprasellar, and left parasellar mass lesion measuring approximately 2.8 cm, causing optic chiasmal compression, left medial temporal lobe mass effect, and extension toward the left sphenoid sinus. Findings are most consistent with a pituitary macroadenoma with left parasellar/sphenoidal extension.

≈ Abnormal LEFT superior peri-sylvian cortical sulcal/gyral pattern with prominent adjacent extra-axial CSF spaces, likely representing a developmental cortical anomaly/malformation of cortical development with focal regional volume loss and underdevelopment. Correlation with clinical history is advised.

Dr. Ramy El-Youkhy, MD

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



اسماء
عادل راشد ابوسريع
٢٧ ح الشراقوه
مصر القديمة - القاهرة

١٩٩٨/٠٨

٢٩٨٠٨٢٧٠١٠٣٨٨٦

LP0362951





Patient Name: أسماء عادل راشد

Study Date: 18/07/2026 07:50:44 PM

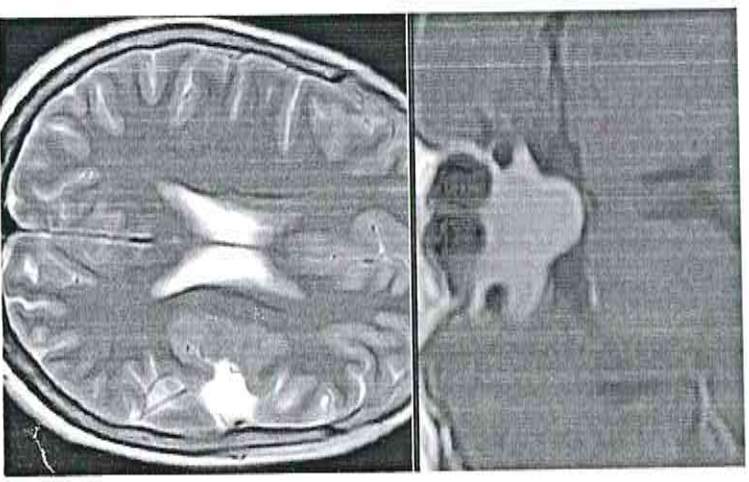
DYNAMIC M.R.I. OF THE SELLA TURCICA

Technique: Sagittal T1 & T2. Coronal T1 & T2. Post I.V. Contrast dynamic WIs.

Findings:

* Large sellar, suprasellar, and left parasellar enhancing soft tissue mass lesion measuring approximately $2.4 \times 2.5 \times 2.8$ cm. The lesion demonstrates mass effect upon the optic chiasm and impression upon the left medial temporal lobe. The mass extends into the left cavernous sinus with encasement of the cavernous segment of the left internal carotid artery, without definite evidence of arterial narrowing or occlusion. The lesion shows inferior extension with encroachment upon the superior aspect of the left sphenoid sinus/cavity. The pituitary gland and stalk are not separately delineated from the lesion.

* Additional abnormal cortical sulcal and gyral configuration is noted at the superior aspect of the left Sylvian cistern region, associated with prominence of the overlying extra-axial CSF spaces.



Conclusion:

≈ Large enhancing sellar, suprasellar, and left parasellar mass lesion measuring approximately 2.8 cm, causing optic chiasmal compression, left medial temporal lobe mass effect, and extension toward the left sphenoid sinus. Findings are most consistent with a pituitary macroadenoma with left parasellar/sphenoidal extension.

≈ Abnormal LEFT superior peri-sylvian cortical sulcal/gyral pattern with prominent adjacent extra-axial CSF spaces, likely representing a developmental cortical anomaly/malformation of cortical development with focal regional volume loss and underdevelopment. Correlation with clinical history is advised.

Dr. Ramy El-Youkhy, MD

تقریر طبعی

بشأن تقرير طبي للمريض: ١- حالة عائلتي

66 Laurel

تقریر طبعی

بشأن تقرير طبي للمريض: ١- حالة عائلتي

66 Laurel

Medical No. : 8029
Patient's Name: Asmaa Adel Rashid Abou Sreih
Date: 2026-09-29
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



MRI EXAMINATION OF THE BRAIN

Technique:

- Axial T1, T2, FLAIR
- Coronal T2
- Sagittal T1
- DWI &ADC
- Post Gadolinium DTPA Axial, sagittal & Coronal T1 WtIs

Findings:

Status follow up post-operative, compared to previous study dated 30-8-2026, the current study showing no appreciable time interval changes as regards the previously noted:

- Operative bed showing large sellar, suprasellar, and left parasellar enhancing soft tissue mass lesion measuring approximately 2.3x1.9x2.1 cm. The lesion demonstrates mass effect upon the optic chiasm and impression upon the left medial temporal lobe. The mass extends into the left cavernous sinus with encasement and medial displacement of the cavernous segment of the left internal carotid artery, yet persevered signal void signal The lesion shows inferior extension with encroachment upon the superior aspect of the left sphenoid sinus/cavity. The pituitary gland and stalk are not separately delineated from the lesion.
- Abnormal cortical sulcal and gyral configuration with thickening is noted at the superior aspect of the left Sylvian cistern region, associated with prominence of the overlying extra-axial CSF spaces.
- No cerebellar or brain stem areas of altered MR signal.
- Normal size and configuration of the supra and infra tentorial ventricular system
- No midline shift or deformity
- No gross posterior fossa abnormalities.
- Intact cervico medullary junction.

OPINION:

- Status follow up showing rather stationary course since last study.

Dr.Nourhan Ewis